



Automatización del reagendamiento de citas médicas

OPTIMUSDATE

CESFAM de Providencia

Integrantes del equipo - Capstone Intermedio 2026

María José Bustamante Ing. Civil Industrial

Vania Cuicui Ing. Civil Industrial

Daniela Pizarro Ing. Civil Industrial

Eduardo Monsalves Ing. Civil en Electrónica

Oscar Díaz Ing. Civil en Electrónica

Ian Olivares Ing. Civil en Electrónica



ROLES DEL EQUIPO



- Eduardo Monsalves — Coordinador General
- Ian Olivares — Analista de Datos
- Daniela Pizarro — Control de Calidad y Pruebas
- María Bustamante — Experiencia de Usuario (UX) y Enlace
- Vania Cuicui — Prototipado y Operaciones
- Oscar Díaz — Soporte Técnico e Investigación



¿CUÁL ES EL PROBLEMA ?

Contexto

- CESFAM Providencia (Atención Primaria de Salud).
- Alta demanda y diversidad de usuarios (adultos mayores, etc.).

Problemática Central

- Pérdida de horas por inasistencias de pacientes.
- Gestión de reagendamiento y seguimiento de alto riesgo.

Declaración del Objetivo del Proyecto

- Verbo: Automatizar
- ¿Qué?: Reducción del tiempo de trabajo manual en reagendamiento.
- ¿Cómo?: Prototipo digital desacoplado sin costo de licencias.
- ¿Cuándo?: Semestre Primavera 2026 (Curso Capstone Intermedio).

¿A QUIÉN AFECTA?

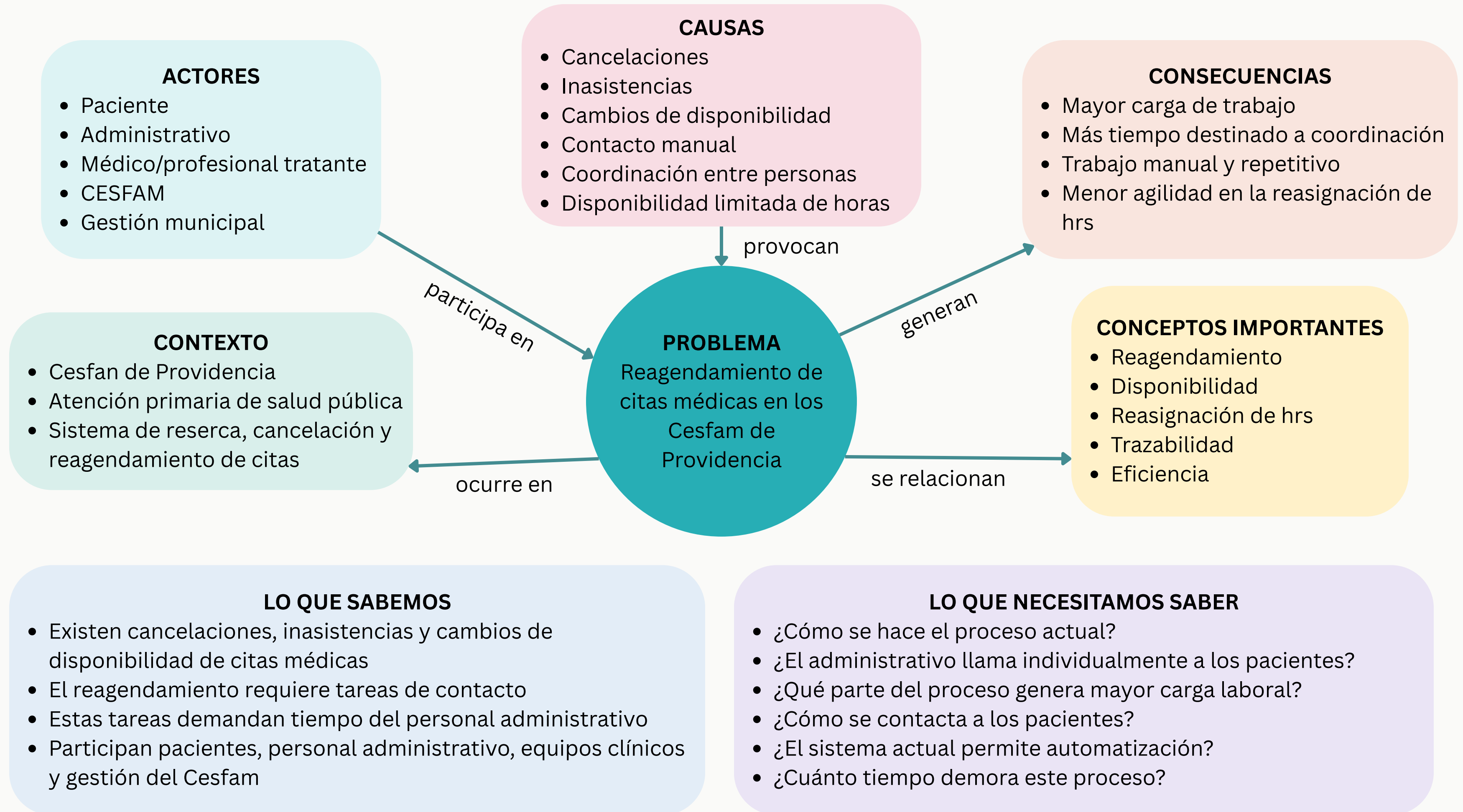
- Personal administrativo
- Pacientes
- Profesionales de salud
- Gestión del CESFAM

CONSECUENCIAS

- Mayor carga administrativa
- Tiempo dedicado a llamadas y coordinación
- Horas médicas que pueden quedar disponibles
- Retrasos en controles y atenciones
- Dificultades para pacientes con menor manejo tecnológico.



MAPA CONCEPTUAL



PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

CESFAM PROVIDENCIA



- ° ¿Podría explicarnos el procedimiento que hace a la hora de reagendar una cita médica?
- ° ¿Es común ver muchas citas canceladas o horas que deben ser reasignadas a la semana?
- ° ¿Qué escucha normalmente de los pacientes que se le cancelan las citas médicas?
- ° ¿Qué siente a la hora de reagendar citas, considera que es un procedimiento engorroso y que le dedica mucha parte de su tiempo?
- ° ¿Qué implementación piensa que podría facilitar su trabajo a la hora del reagendamiento de citas?



MAPA DE EMPATÍA

¿Qué piensa y siente?

- Siente presión cuando se acumulan cancelaciones y cambios.
- Le preocupa cometer errores al coordinar nuevas horas.
- Se siente frustrado cuando los pacientes no responden.
- Piensa que su trabajo podría ser más ágil y eficiente.

¿Qué oye?

- Avisos de cancelaciones e inasistencias.
- Consultas sobre nuevas fechas disponibles.
- Solicityd de cambiui de citas.
- Quejas sobre reagendamento.

¿Qué ve?

- Citas canceladas.
- Horas que deben ser reasignadas.
- Listas de espera y alta demanda.
- Pacientes que no asisten a sus horas.
- Tareas administrativas.

¿QUIÉN?

Queremos comprender el problema desde la perspectiva del **personal administrativo de los CESFAM**, porque son quienes actualmente realizan gran parte de las tareas de contacto y coordinación asociadas al reagendamento.

¿Qué dice y hace?

- Contacta pacientes
- Coordina cambios de citas entre pacientes y profesionales
- Revisa la disponibilidad de horas en el sistema

Esfuerzo

- Dedicar tiempo a contactar, coordinar y encontrar una nueva hora adecuada.

Resultados

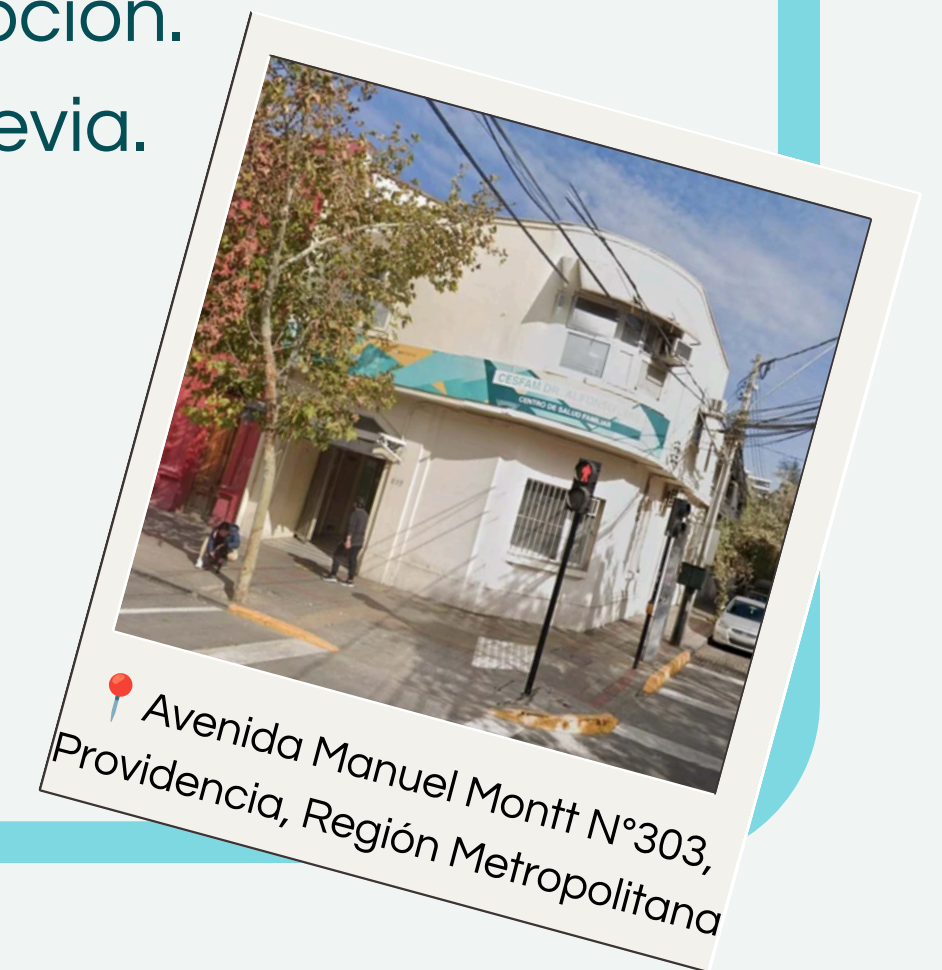
- Conseguir que la cita sea reagendada y que el proceso quede correctamente gestionado.

HALLAZGOS DE INVESTIGACIÓN

VISITA A CESFAM PROVIDENCIA



- Supuesto descartado: La confirmación de citas ya se encuentra automatizada (vía WhatsApp y llamadas).
- El verdadero cuello de botella: 60% a 70% de la jornada laboral se destina al registro manual de llegada de pacientes en recepción.
- Conducta del paciente: Alta inasistencia sin cancelación previa.
- Impacto operativo: Obliga al personal a realizar un "rescate telefónico activo" para pacientes de alto riesgo.

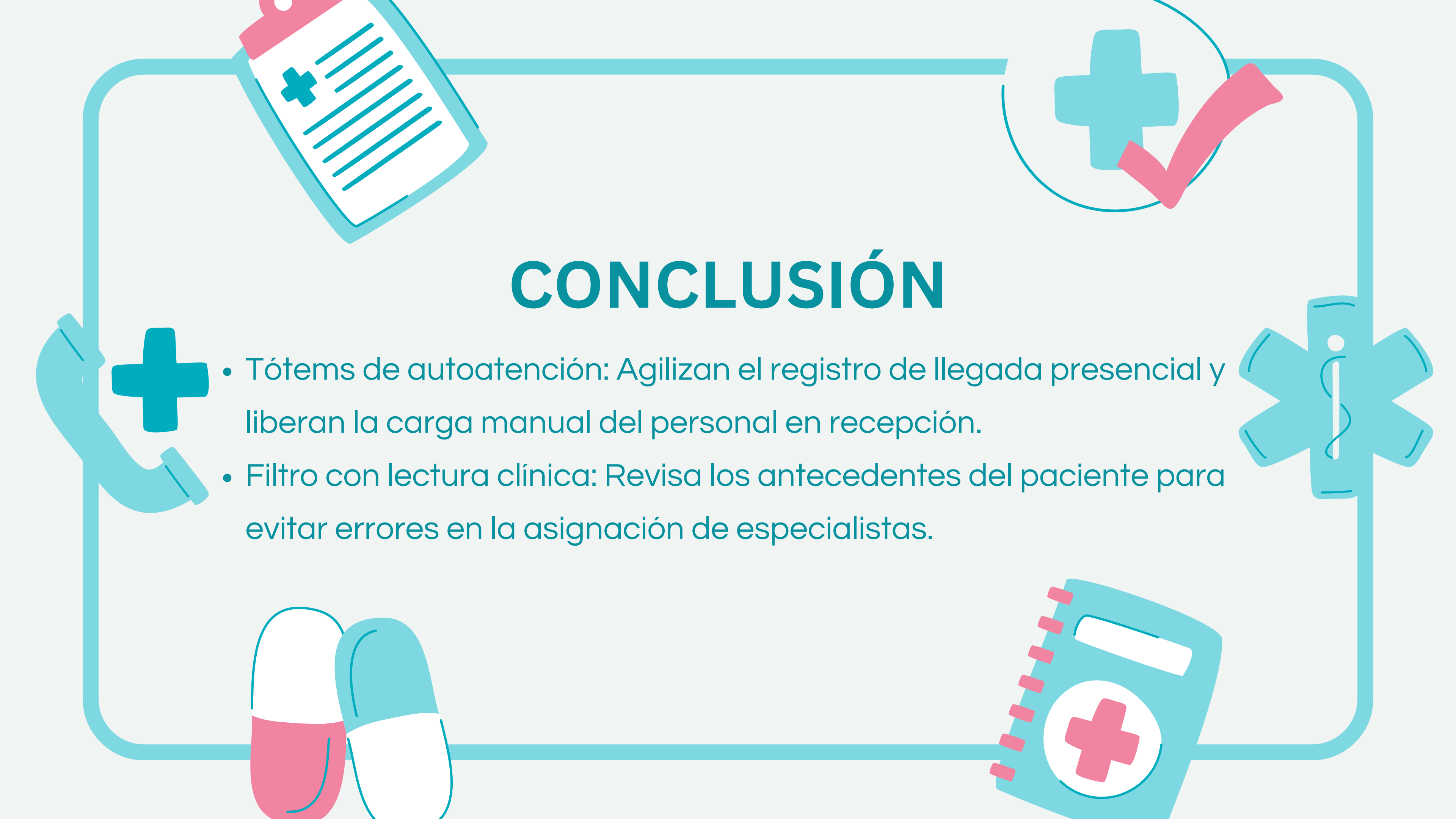


Avenida Manuel Montt N°303,
Providencia, Región Metropolitana

GITHUB

[illegible]

Más información detallada en nuestro repositorio.



CONCLUSIÓN

- Tótems de autoatención: Agilizan el registro de llegada presencial y liberan la carga manual del personal en recepción.
- Filtro con lectura clínica: Revisa los antecedentes del paciente para evitar errores en la asignación de especialistas.